

Endometriosis y Adenomiosis

1. Introducción y relevancia clínica

La **endometriosis** y la **adenomiosis** son enfermedades benignas **dependientes de estrógenos**, caracterizadas por la **presencia ectópica de tejido endometrial funcional**, fuera o dentro del útero respectivamente.

- **Endometriosis:** glándulas y estroma endometrial fuera de la cavidad uterina (ej. ovarios, trompas, peritoneo).
- **Adenomiosis:** glándulas endometriales dentro del **miometrio**.

Ambas entidades generan **dismenorrea secundaria, dolor pélvico crónico e infertilidad**, afectando de forma importante la calidad de vida y la función reproductiva de la mujer.

□ En EUNACOM suelen preguntar:

- Diferencias entre endometriosis y adenomiosis.
 - Manifestaciones clínicas y diagnóstico.
 - Tratamiento médico hormonal y quirúrgico.
 - Relación con infertilidad y manejo según deseo gestacional.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Endometriosis

Definición

Presencia de **glándulas y estroma endometrial funcional fuera del útero**, principalmente en:

- Ovarios (endometrioma).
- Peritoneo pélvico (fosas ováricas, ligamentos uterosacros).
- Trompas, tabique rectovaginal, vejiga o intestino.

Teorías fisiopatológicas

1. **Menstruación retrógrada (Sampson):** el flujo menstrual refluye por las trompas e implanta células endometriales en el peritoneo.
2. **Metaplasia celómica:** células peritoneales se transforman en endometriales bajo estímulo hormonal.
3. **Diseminación linfática o hematógena:** explica focos en sitios distantes (pulmón, cicatrices).

Influencia hormonal

- Estimula proliferación cíclica de los focos ectópicos → sangrado, inflamación y fibrosis → dolor y adherencias.

b. Adenomiosis

Definición

Infiltración del **endometrio hacia el miometrio**, formando islotes de tejido endometrial dentro del músculo uterino.

Mecanismo

Se asocia a **trauma uterino repetido** (partos, legrados, cesáreas) y al **exceso estrogénico**, que favorece la invasión endometrial.

Efecto

Provoca **aumento del tamaño uterino, dismenorrea progresiva y metrorragia**.

3. Epidemiología

Característica	Endometriosis	Adenomiosis
Edad típica	25–40 años	35–50 años

Paridad	Nulípara	Multípara
Asociación	Infertilidad	Sangrado uterino anormal
Resolución	Mejora con embarazo o menopausia	Desaparece en menopausia

4. Clínica

Síntoma	Endometriosis	Adenomiosis
Dismenorrea	Secundaria, progresiva	Intensa y progresiva
Dolor pélvico crónico	Constante o cíclico	Asociado a menstruación
Dispareunia profunda	Frecuente	Poco común
Metrorragia / hipermenorrea	Ocasional	Muy frecuente
Infertilidad	Frecuente	Rara
Aumento de volumen uterino	No	Sí (útero globuloso, blando, doloroso)

5. Diagnóstico diferencial

Cuadro	Diferencia clave
Miomas uterinos	Útero duro, irregular, bien delimitado
Enfermedad inflamatoria pélvica	Fiebre, leucocitosis, dolor agudo
Cáncer de endometrio	Metrorragia posmenopáusica
Dismenorrea primaria	Sin hallazgos ecográficos o anatómicos
Dolor pélvico funcional	Sin correlato anatómico ni inflamatorio

6. Exámenes complementarios

a.

Ecografía transvaginal

- Primer examen de elección.
- Endometrioma: imagen quística de paredes gruesas y contenido homogéneo (“vidrio esmerilado”).
- Adenomiosis: útero aumentado, heterogéneo, sin bordes definidos.

b.

Resonancia magnética (RM)

- Alta sensibilidad para lesiones profundas o adenomiosis difusa.

c.

Marcadores séricos

- **CA-125:** puede elevarse, pero es inespecífico.
- Útil en seguimiento, no diagnóstico.

d.

Laparoscopia diagnóstica

- **Gold standard** para endometriosis.
- Permite diagnóstico visual y biopsia histológica.
- También puede tratar lesiones durante el mismo procedimiento.

7. Clasificación de la endometriosis (ASRM, 2021)

Grado	Características
I (mínima)	Implantes superficiales aislados
II (leve)	Implantes superficiales múltiples
III (moderada)	Implantes profundos, adherencias leves
IV (severa)	Endometriomas grandes, adherencias densas, obstrucción tubárica

8. Tratamiento de la endometriosis

El tratamiento depende de **la intensidad del dolor y del deseo de fertilidad.**

A.

Tratamiento médico

1. Objetivo:

Inhibir la estimulación hormonal de los focos endometriales → reducir dolor y regresión de lesiones.

2. Opciones:

Grupo	Ejemplos	Mecanismo	Comentarios
AINES	Ibuprofeno, naproxeno	Inhiben prostaglandinas	Para dismenorrea leve
ACO combinados	Etinilestradiol + levonorgestrel	Inhiben ovulación	Primera línea, continuos o cíclicos
Progestágenos	Acetato de medroxiprogesterona, dienogest	Atrofia endometrial	Alternativa útil y económica
DIU liberador de LNG (Mirena®)	Levonorgestrel local	Disminuye sangrado y dolor	Eficaz y de larga duración
Análogos de GnRH	Leuprolida, goserelina	Hipoestrogenismo reversible	Segunda línea; usar máx. 6 meses
Danazol	Antiestrogénico, androgénico	Induce pseudo-menopausia	Poco usado por efectos virilizantes

❑ El uso continuo de ACO o progestinas **simula embarazo o menopausia**, reduciendo actividad endometriósica.

B.

Tratamiento quirúrgico

Indicaciones:

- Dolor severo refractario a manejo médico.
- Endometriomas >4 cm.
- Infertilidad por adherencias o obstrucción tubárica.
- Sospecha de malignidad.

Opciones:

- **Laparoscopia:** resección o coagulación de lesiones, lisis de adherencias.
- **Quistectomía ovárica:** para endometriomas.
- **Histerectomía ± ooforectomía:** en mujeres sin deseo de fertilidad y enfermedad avanzada.

☐ La cirugía mejora la fertilidad, pero debe equilibrarse con la preservación ovárica.

9. Tratamiento de la adenomiosis

Objetivo	Tratamiento
Control del sangrado	ACO, progestinas, DIU-LNG
Control del dolor	AINEs, GnRH
Deseo de fertilidad	Manejo médico conservador

No deseo de fertilidad o refractaria

Histerectomía total

La **histerectomía** es el tratamiento definitivo para adenomiosis severa con sangrado o dolor refractario.

10. Infertilidad asociada a endometriosis

- La endometriosis causa **adhesiones peritubáricas, inflamación pélvica e implantación alterada.**
- El tratamiento quirúrgico mejora la fertilidad natural.
- En casos persistentes: **fertilización in vitro (FIV).**

☐ El manejo conservador es prioritario en mujeres jóvenes con deseo gestacional.

11. Complicaciones

Complicación	Comentario
Infertilidad	Por adherencias y daño tubárico
Dolor pélvico crónico	Por inflamación y fibrosis
Degeneración maligna	<1% (carcinoma endometrioide, ovario)
Anemia	Por metrorragia crónica en adenomiosis

12. Pronóstico y seguimiento

- Enfermedad **crónica y recidivante**.
 - Mejoría durante embarazo o menopausia.
 - Seguimiento clínico y ecográfico anual.
 - Control de hemoglobina y calidad de vida.
-

13. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Endometriosis**: tejido endometrial fuera del útero; **adenomiosis**: dentro del miometrio.
2. **Dismenorrea progresiva + infertilidad = endometriosis.**
3. **Útero aumentado, blando y doloroso = adenomiosis.**
4. **Ecografía transvaginal** es el examen inicial.
5. **Laparoscopia** es el **gold standard** para diagnóstico y tratamiento.
6. **ACO o progestágenos** son tratamiento médico de primera línea.
7. **GnRH y histerectomía** se reservan para casos severos o refractarios.



Errores comunes

- No sospechar endometriosis en dismenorrea secundaria.
- Indicar cirugía temprana sin intentar manejo médico.
- No diferenciar endometrioma ovárico de quiste funcional.

- Ignorar infertilidad asociada.
 - Olvidar seguimiento por recidiva.
-

14. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **endometriosis** y la **adenomiosis** son enfermedades **dependientes de estrógenos y benignas**.
2. **Endometriosis**: fuera del útero; **adenomiosis**: dentro del miometrio.
3. Síntomas: **dismenorrea progresiva, dolor pélvico, infertilidad o metrorragia**.
4. **Ecografía transvaginal** y **laparoscopia** son claves para el diagnóstico.
5. **Tratamiento médico**: ACO, progestinas, DIU-LNG, GnRH.
6. **Tratamiento quirúrgico** en refractarias o con deseo reproductivo.
7. **Histerectomía** es el tratamiento definitivo para adenomiosis severa.